

CD 7312 952 F39E
H3692 4182 D813

INDICADO POR: Dr. Flávio Serafini / Felipe

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J37155640D7B4

NATALIA PEREIRA

IDADE: 27 PESO: 32 ALTURA: 125 PROFISSÃO: *n faz ativi / prof.*

SINTOMAS: *Sonolência (dorme no carro)*

QUEIXAS: *Sempre acorda cansada.*

MEDICAMENTOS: *Puram*

MÉDICO: *Drº Flávio Serafini*

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: *2x pilates / Educação física 4x*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23 HORA QUE ACORDA: 7h

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: *0x*

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: *normal* CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: *não* MALLAMPATI: *IV* IAH: 14 SPO2: 84%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *Tireoide* (*↑ Hemácias nos exames de retina*)
hiperferridemia

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: — PRESSÃO NO EXAME: —

10/04 Avaliação
— 25

16/04/25 *Ana consulta.*

25/04/25 *Analiando Remédio > ↑ P: 4,5 cmH2O à 7,0 cmH2O*

P95%: 6,0 cmH2O

IAH: 8,01h (AO: 3,1 AC: 1,8 Hp: 3,1)

fuga = 8

muco = 8h30min

Sua

07/05 P= 6,0 medicina

Bem adaptada.

— 25 IAH = 6,9 eh

m. de uso: 8h41'

Sua

fuga = 0,0

03/07
25

Dias 30d.

P = 6,0 cmHg

IAH = 8,7 e leu

Fuga = 0"

M. de uso: 8h42'

Sem adaptado.

fu.

IDADE:	17	PESO:	55	ALTURA:	1,72	PROFISSÃO:	
SINTOMAS:							
QUEIXAS:							
MEDICAMENTOS:							
MEDICO:							
MARCAPASSO: () S () N	COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N						
EXERCÍCIO FÍSICO:							
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:							
HORA QUE DORME:							
COCHILHO: () S () N	DORME ACOMPANHADO: () S () N						
TEM FILHOS: () S () N	DORME NO QUARTO: () S () N						
BEBIDA ALCOOLICA: () S () N	X NA SEMANA: () N						
FUMO: () S () N	MAÇÓDIA: () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:						
TIPO DE RESPIRAÇÃO:	CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:						
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:						
OVERLAP:	MALLAMPATI: () IAH: () SPO2: ()						
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:							
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA							
HIPERTENSÃO DA OBESIDADE:							
COMORBIDADE: () RESPIRATORIA () ENDOCRINA () CARDÍACA							
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:							
POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S () N	SPO2 CPAP: () PRESSÃO NO EXAME: ()						



Clínica Serafini

Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia

Tratamento Clínico e cirúrgico do ouvido, nariz e garganta
Otorrinolaringologia Pediátrica
Otoneurologia
Rinologia

P/ Natalia Pereira

Solicito adaptar CPAP para

sono e apneia.

a queda na oxigenação
está aumentando hemoglobina
e contagem.



Prof. Dr. Flávio Serafini

CRM 73542

Tratamento Cirúrgico e
Clínico das Doenças do
Orelha, Nariz e Garganta

Prof. Dr. Flávio Serafini
CRM 73.542

Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado.
Universidade Federal de São Paulo UNIFESP
Chefe e Professor da Disciplina de Otorrinolaringologia da UNITAU

Edifício Liberal Center:

Rua Dr. Frederico Machado, 132 - sala 38
CEP 12.410-040 - Pindamonhangaba - SP
Tel.: (12) 3642-5111 / (12) 99215-3112

Laudo de Polissonografia: Resultado

Nome: NATALIA PEREIRA			Escala Epworth: 1
Sexo: F	Idade: 27 anos	Peso: 32 Kg	Altura: 1,30 m
IMC: 18,9	Data do Exame: 18/03/2025	Exame: 07708_01	
Médico solicitante: DR. FLAVIO SERAFINI			CONVÊNIO: PARTICULAR

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:49:18 horas e encerrado às 06:03:44 horas, com latência para o sono de 4 minutos e latência para o sono REM de 370 minutos. O tempo total de sono foi de 399,0 minutos, com eficiência do sono de 92,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	13,8%	Até 5%
Estágio 2	61,9%	45 - 55%
Estágio 3	21,7%	> 15%
Sono REM	2,6%	20 - 25%
Eficiência do sono	92,5%	> 85%

No período total de sono permaneceu 32,5 minutos acordado e ocorreram 105 despertares (índice de 15,8 /hora). Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 61 bpm, a maior de 82 bpm e a menor de 49 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora.

- Ocorreram 93 eventos respiratórios, sendo 3 centrais e 90 obstrutivos.
- O índice de apnéia/hipopnéia total foi 14,0/hora, sendo 3,3 apnéia/hora e 10,7 hipopnéia/hora.
- O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 5,7/hora, sendo 5,7 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora.
- Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos e índice de 0,0/h.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 98%, sendo a saturação média de 95%, a maior de 99% e a mínima de 84%, permanecendo 2,9 minutos (0,7%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 57 dessaturações.

Resumo dos resultados

- 1 – Índice de apnéia e hipopneia levemente aumentado;
- 2 – Dessaturação da oxi-hemoglobina, associada a eventos respiratórios;
- 3 – Ronco presente;
- 4 – Latência para o sono REM aumentada;
- 5 – Eficiência do sono normal;
- 6 – Diminuição da porcentagem do sono REM;
- 7 – Índice de despertares breves aumentado.
- 8 – Não observado registro significativo alterações eletrocardiográficas;
- 9 – Não observado registro de índice significativo de movimento periódico de membros inferiores;
- 10 – Não observado registro significativo de períodos de aumento sustentado do tônus muscular, compatíveis com bruxismo.

Dra. Dinália Ribeiro Nascif
Pneumologista
CRM: 84366 – RQE: 52369